

Eduface testdag

Master Manuele Therapie

CAT diagnostiek · student 1 · nagekeken op 09-12-2025

Naam _____ Datum _____

BEOORDELINGSOPTIE **Voldaan of niet voldaan, per rubriekcriterium**

Beoordeling naast elkaar

	NAKIJKER	EDUFACE	
1. Algemeen	4 van 4 voldaan	Niet voldaan	VERSCHIL
2. Klinisch scenario (stap 1)	2 van 3 voldaan	Voldaan	OMGEKEERD
3. Klinische vraagstelling (stap 2)	5 van 5 voldaan	Voldaan	EENS
4. Zoekstrategie (stap 3)	6 van 6 voldaan	Niet voldaan	VERSCHIL
5. Kritische evaluatie (stap 4)	2 van 2 voldaan	Voldaan	EENS
6. Evidentietabel (stap 5)	2 van 2 voldaan	Niet voldaan	VERSCHIL
7. Commentaar (stap 6)	2 van 2 voldaan	Niet voldaan	VERSCHIL
8. Bottom line (stap 7)	1 van 1 voldaan	Niet voldaan	VERSCHIL

NAKIJKER

24 van 25 voldaan

Eindoordeel: voldaan

EDUFACE

3 van 8 voldaan

Vijf onderdelen niet voldaan

OVEREENSTEMMING

2 van de 8

Vijf keer strenger, één keer milder

Feedback van de nakijker

"Hey [student], Deze opdracht heb je afgerond. Je hebt hier en daar wel wat kort door de bocht uitgevoerd. Maar dat is bij deze opdracht nog niet z'n probleem."

Aantekeningen

Feedback van Eduface

Per rubriekcriterium, letterlijk

1. Algemeen Niet voldaan

De CAT bevat taal- en terminologiefouten en maakt redenering tussen stappen 1 tot 7 onvoldoende controleerbaar; vooral stap 4 tot 6 missen onderbouwing van interne validiteit, diagnostische kernmaten en bruikbaarheid. Dit verhindert navolgbaarheid. Corrigeer formuleringen en terminologie, verwijder ChatGPT-tekst; voeg zoekdatum, databank, zoektermen, voorafkansen, in- en exclusiecriteria en berekeningen toe en verbind ze met bottom line.

2. Klinisch scenario (stap 1) Voldaan

Bij stap 1 presenteer je patiëntkenmerken en onderzoeksbevindingen kernachtig en verbind je deze logisch aan de hypothese. Echter, formuleer de hypothesen vóór de bevindingen en onderscheid welke bevindingen specifiek labrumletsel ondersteunen. Onderbouw de lage voorafkansen (onder 10%) voor deze patiënt en corrigeer de genoemde taal- en grammaticafouten.

3. Klinische vraagstelling (stap 2) Voldaan

Je hebt de klinische vraag logisch opgebouwd: patiënt, indextest, referentietest, aandoening, NVW, voorafkansen en beslisgrens zijn expliciet en toetsbaar verbonden. Echter, de voorafkansen onder 10% is nog niet patiëntspecifiek onderbouwd. Harmoniseer vervolgens voorafkansen, labrumletsel en referentietest en corrigeer de NVW/PVW-inconsistentie in bijlage 2.

4. Zoekstrategie (stap 3) Niet voldaan

De reproduceerbaarheid van stap 3 en de onderbouwing van de artikelkeuze zijn incompleet; daardoor kan de lezer de zoekactie en casustoepasbaarheid niet controleren. Noteer datum, exacte PubMed-zoekstring met MeSH-termen en Booleaanse operatoren, faseaantallen en selectieargumenten. Vergelijk elk inclusie- en exclusiecriteria met de casus.

5. Kritische evaluatie (stap 4) Voldaan

Je koppelt methodologische kenmerken terecht aan verificatie- en expectation bias en verbindt meerdere beperkingen aan Adib et al. (2023). Echter, maak in stap 4 per punt expliciet welk kenmerk welke bias en welk gevolg veroorzaakt. Bespreek in stap 5 referentiestandaard, beoordelaarsbetrouwbaarheid en work-up-, selectie- en spectrum bias.

6. Evidentietabel (stap 5) Niet voldaan

Stap 5 en Bijlage 1 bevatten foutieve formules; daardoor zijn de berekeningen oncontroleerbaar. Noteer per maat formule, invulling, uitkomst en afronding, koppel waarden aan Tabel 1, corrigeer $0,94 \times 100$ en $0,33 \times 900$ en schrijf PVW als $94/697 = 13,5\%$. Orden artikel en 10%-voorafkansen in hypothetische 2×2 -tabellen van 1.000 personen.

7. Commentaar (stap 6) Niet voldaan

Stap 6 werkt de klinische bruikbaarheid onvoldoende uit: de betekenis van een NVW van 0,98 en de lage specificiteit van 0,33 blijft onverbonden met patiënt en werkomgeving. Dit verhindert een onderbouwde toepasselijkheidsuitspraak. Bespreek wanneer een negatieve test MRA kan uitstellen en controleer berekeningen en bronnen.

8. Bottom line (stap 7) Niet voldaan

Je Bottom Line maakt niet expliciet wat een negatieve Arlington-test betekent voor het diagnostische traject. Daardoor blijft de klinische handelingskeuze onduidelijk. Formuleer in één à twee zinnen of MRA direct geïndiceerd is en welke rol klinische follow-up speelt, rekening houdend met de beperkte generaliseerbaarheid.

Waar het uiteenloopt

De grootste verschillen

Evidentietabel (stap 5)

NAKIJKER

Beide criteria voldaan. De tabel met sensitiviteit, specificiteit en voorspellende waarden werd goedgekeurd.

EDUFACE

Niet voldaan. "Stap 5 en Bijlage 1 bevatten foutieve formules; daardoor zijn de berekeningen oncontroleerbaar. Corrigeer $0,94 \times 100$ en $0,33 \times 900$ en schrijf PVW als $94/697 = 13,5\%$."

Klopt die rekenkundige correctie? En als het klopt, is dit iets wat jullie zelf ook zouden willen zien?

Algemeen

NAKIJKER

Alle vier de criteria voldaan: taalgebruik, woordenaantal, samenhang en titel.

EDUFACE

Niet voldaan. "De CAT bevat taal- en terminologiefouten (...) Corrigeer formuleringen en terminologie, verwijder ChatGPT-tekst."

Zijn die taalfouten terug te vinden in de tekst, en is de passage aan te wijzen die het model bedoelt?

Klinisch scenario (stap 1), hier lag de lat van de nakijker hoger

NAKIJKER

Niet voldaan op één punt: het accent op de klinische relevantie en de motivatie voor de klinische vraag ontbrak.

EDUFACE

Voldaan. Het model tekent er wel bij aan dat de lage voorafkans onder 10% niet patiëntspecifiek is onderbouwd.

Hier zag de nakijker iets dat het model niet noemt. Wat was dat, zodat we het kunnen meenemen?

Aannames van het model

Waar het model invult wat de rubriek openlaat

Geen van deze is fout of goed. Het zijn keuzes.

1. Eén spoor of meerdere sporen

HET MODEL SCHRIJFT "Formuleer de hypothesen vóór de bevindingen en onderscheid welke bevindingen specifiek labrumletsel ondersteunen."

DE RUBRIEK ZEGT het woord hypothesen, meervoud, zonder aantal

IN DEZE BEOORDELING is één onderbouwde hypothese gevolgd, met de bevindingen ernaartoe geredeneerd

Het model leest dat meervoud letterlijk en vraagt om een vergelijking tussen meerdere mogelijke oorzaken. Verwachten jullie dat ook, of is één goed onderbouwd spoor genoeg?

2. Hoe ver moet een zoekactie navolgbaar zijn

HET MODEL SCHRIJFT "Noteer datum, exacte PubMed-zoekstring met MeSH-termen en Booleaanse operatoren, faseaantallen en selectieargumenten. Vergelijk elk inclusie- en exclusiecriterium met de casus."

DE RUBRIEK ZEGT dat de zoekstrategie navolgbaar en reproduceerbaar is

IN DEZE BEOORDELING is een gemotiveerde keuze voor de gevonden artikelen voldoende bevonden, zonder dat de afgewezen artikelen apart besproken worden

Het model wil de zoekactie zo volledig dat iemand hem kan overdoen, inclusief de argumenten voor wat er afviel. Is dat wat jullie van een student op dit niveau verwachten?

3. Mag het model iets zeggen over de herkomst van de tekst

HET MODEL SCHRIJFT "Corrigeer formuleringen en terminologie, verwijder ChatGPT-tekst."

DE RUBRIEK ZEGT niets over de herkomst van de tekst

IN DEZE BEOORDELING is het taalgebruik als voldaan beoordeeld

Dit is het enige punt waarop het model buiten de rubriek treedt. Willen jullie dat het daar iets over zegt, en zo ja, hoe stellig mag dat zijn?

4. Weegt elk onderdeel apart, of het geheel

WAT HET MODEL DOET het beoordeelt elk onderdeel los en zet vijf van de acht op niet voldaan

DE RUBRIEK ZEGT per criterium voldaan of niet voldaan, met een apart eindoordeel

IN DEZE BEOORDELING zijn 24 van de 25 criteria voldaan en is het eindoordeel voldaan

Het model zet elk onderdeel als een aparte drempel. In deze beoordeling woog het geheel mee. Welke van de twee past bij hoe jullie willen beoordelen?

Van de acht stukken feedback: hoeveel zou je ongewijzigd naar de student sturen?

Wat miste je, dat je zelf wél zou hebben opgemerkt?

Beoordelingsformulier

Voor een van de andere opdrachten

Naam _____

Datum 23-09-2026

Dit blad gaat over ☐ Manuele Therapie ☐ Kinderfysiotherapie ☐ POH-6

Voordat we beginnen: hoeveel tijd kost het je nu om één zo'n opdracht na te kijken? _____ minuten

1 Per rubriekcriterium: zou je deze feedback doorsturen?

Schrijf links het criterium, zet dan links één kruisje en rechts of je tot hetzelfde oordeel zou komen.

	STUUR IK ZO DOOR	NA KLEINE AANPASSING	SCHRAP IK	OORDEEL KLOPT	OORDEEL KLOPT NIET
1 _____	☐	☐	☐	☐	☐
2 _____	☐	☐	☐	☐	☐
3 _____	☐	☐	☐	☐	☐
4 _____	☐	☐	☐	☐	☐
5 _____	☐	☐	☐	☐	☐
6 _____	☐	☐	☐	☐	☐
7 _____	☐	☐	☐	☐	☐
8 _____	☐	☐	☐	☐	☐

2 Toon en bruikbaarheid

	NEE	DEELS	GROTENDEELS	JA	N.V.T.
De feedback klinkt alsof hij van onze opleiding komt.	☐	☐	☐	☐	☐
De feedback is concreet genoeg om iets mee te doen.	☐	☐	☐	☐	☐
Ik kan zien waar het oordeel op gebaseerd is.	☐	☐	☐	☐	☐

3 Wat viel op

Welke opmerking was de beste?

Welke zou je als eerste schrappen?

Wat miste je, dat je zelf wél zou hebben opgemerkt?

Wat zou dit voor jou bruikbaar maken?

Beoordelingsformulier

Voor een van de andere opdrachten

Naam _____

Datum 23-09-2026

Dit blad gaat over ☐ Manuele Therapie ☐ Kinderfysiotherapie ☐ POH-6

Voordat we beginnen: hoeveel tijd kost het je nu om één zo'n opdracht na te kijken? _____ minuten

1 Per rubriekcriterium: zou je deze feedback doorsturen?

Schrijf links het criterium, zet dan links één kruisje en rechts of je tot hetzelfde oordeel zou komen.

	STUUR IK ZO DOOR	NA KLEINE AANPASSING	SCHRAP IK	OORDEEL KLOPT	OORDEEL KLOPT NIET
1 _____	☐	☐	☐	☐	☐
2 _____	☐	☐	☐	☐	☐
3 _____	☐	☐	☐	☐	☐
4 _____	☐	☐	☐	☐	☐
5 _____	☐	☐	☐	☐	☐
6 _____	☐	☐	☐	☐	☐
7 _____	☐	☐	☐	☐	☐
8 _____	☐	☐	☐	☐	☐

2 Toon en bruikbaarheid

	NEE	DEELS	GROTENDEELS	JA	N.V.T.
De feedback klinkt alsof hij van onze opleiding komt.	☐	☐	☐	☐	☐
De feedback is concreet genoeg om iets mee te doen.	☐	☐	☐	☐	☐
Ik kan zien waar het oordeel op gebaseerd is.	☐	☐	☐	☐	☐

3 Wat viel op

Welke opmerking was de beste?

Welke zou je als eerste schrappen?

Wat miste je, dat je zelf wél zou hebben opgemerkt?

Wat zou dit voor jou bruikbaar maken?
